

- 26★★★ 小細胞癌で血清 CEA が上昇している場合、カルボプラチン＋パクリタキセルが第一選択となる。
☑☑☑

EGFR 遺伝子変異陽性肺癌 27～30

- 27★★★ EGFR ex19 欠失もしくは L858R 陽性例ではパフォーマンスステータス (PS) 4 でもゲフィチニブの投与が考慮される。
☑☑☑
- 28★★★ EGFR ex19 欠失もしくは L858R 陽性例では一次治療でエルロチニブと血管新生阻害薬の併用が選択肢となる。
☑☑☑
- 29★★★ EGFR ex20 挿入変異では EGFR-TKI が奏功する。
☑☑☑
- 30★★★ オシメルチニブは一次治療でも T790M 遺伝子変異陽性例のみでしか使用できない。
☑☑☑

ALK 融合遺伝子陽性肺癌 31～34

- 31★★★ ALK 融合遺伝子陽性例ではダコミチニブを投与できる。
☑☑☑
- 32★★★ ALK 融合遺伝子陽性例ではロルラチニブが一次治療から使用できる。
☑☑☑
- 33★★★ アレクチニブでは味覚障害、筋肉痛、皮疹の他に間質性肺炎の有害事象にも注意が必要である。
☑☑☑
- 34★★★ ロルラチニブでは認知機能低下が重篤な有害事象として報告されている。
☑☑☑

- 35★★★ エヌトレクチニブは ROS-1 融合遺伝子陽性非小細胞肺癌に有効である。
☑☑☑

- 36★★★ ROS-1 融合遺伝子変異陽性例ではダブラフェニブ＋トラメチニブによる治療が推奨される。
☑☑☑

- 37★★★ 非小細胞肺癌に対する検査と治療において、保険適応となっているドライバー遺伝子変異は EGFR、ALK、ROS-1、BRAF、NTRK のみである。
☑☑☑

- 38★★★ テポチニブの主な毒性は末梢浮腫、消化器症状、血清クレアチニン上昇がある。
☑☑☑